

LAPORAN PENDAHULUAN
LAPORAN ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN
SELUSITIS DI RUANG JASMINE RSUD KOTA SERANG



Disusun oleh:

Nama: Salsabila Nuril Adha

NIM 17012200032

UNIVERSITAS BINA BANGSA
PROGRAM STUDI S1-KEPERAWATAN
TAHUN 2026

A. Definisi

Selulitis merupakan salah satu penyakit infeksi pada kulit dan jaringan subkutan yang ditandai dengan proses inflamasi akut akibat invasi mikroorganisme patogen. Peradangan ini umumnya mengenai lapisan dermis dan jaringan subkutan sehingga menimbulkan manifestasi berupa kemerahan, pembengkakan, nyeri, serta peningkatan suhu pada daerah yang mengalami infeksi. Istilah selulitis berasal dari kata *cellule* yang berarti susunan tingkat sel dan *itis* yang berarti peradangan, sehingga secara harfiah selulitis dapat diartikan sebagai proses peradangan yang terjadi pada jaringan sel atau jaringan subkutan (Hasliani, 2021).

Menurut Hasliani (2021), selulitis merupakan inflamasi jaringan subkutan yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus* grup A. Infeksi biasanya terjadi ketika bakteri memasuki tubuh melalui kerusakan pada lapisan kulit, seperti luka terbuka, luka bakar, gigitan serangga, gigitan hewan, maupun luka pascaoperasi. Setelah bakteri masuk ke dalam jaringan, terjadi respons inflamasi yang menyebabkan kerusakan jaringan serta berbagai tanda infeksi lokal maupun sistemik.

Selain disebabkan oleh invasi bakteri, selulitis merupakan salah satu bentuk infeksi kulit dan jaringan lunak (*skin and soft tissue infection*) yang mengenai lapisan dermis hingga jaringan subkutan. Penyakit ini umumnya muncul pada area yang mengalami kerusakan integritas kulit sehingga bakteri lebih mudah memasuki jaringan. Manifestasi khas berupa eritema, edema, nyeri, dan peningkatan suhu lokal dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera ditangani, bahkan berpotensi menyebabkan komplikasi sistemik maupun memerlukan perawatan di rumah sakit (Amalia et al., 2024).

Selulitis dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh, namun lokasi yang paling sering terkena adalah ekstremitas bawah, terutama tungkai dan kaki (pedis), serta wajah. Apabila tidak mendapatkan penatalaksanaan yang tepat, infeksi dapat menyebar ke pembuluh limfe maupun pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang lebih berat, seperti

bakteremia, fasciitis nekrotikan, hingga sepsis. Oleh karena itu, diagnosis dini dan terapi yang adekuat sangat diperlukan untuk mencegah perluasan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan (Hasliani, 2021).

Selain menimbulkan gangguan pada integritas kulit, selulitis juga dapat memengaruhi kondisi fisik pasien secara keseluruhan. Proses inflamasi yang berlangsung menyebabkan timbulnya rasa nyeri, keterbatasan aktivitas, serta gangguan kenyamanan akibat edema dan kerusakan jaringan. Pada kasus yang berat, infeksi dapat berkembang dengan cepat sehingga memerlukan penanganan medis yang segera melalui pemberian antibiotik sesuai indikasi, tindakan drainase apabila terbentuk abses, serta perawatan luka yang komprehensif untuk mengendalikan infeksi, mencegah komplikasi, dan mempercepat proses penyembuhan jaringan (Wiederhold et al., 2024).

B. Etiologi

Non-Selulitis merupakan penyakit infeksi yang sebagian besar disebabkan oleh bakteri patogen yang memasuki jaringan melalui kerusakan pada lapisan kulit. Mikroorganisme tersebut berkembang biak pada jaringan subkutan dan memicu respons inflamasi sehingga menimbulkan gejala berupa kemerahan, pembengkakan, nyeri, serta peningkatan suhu lokal. Menurut Hasliani (2021), penyebab utama selulitis adalah infeksi bakteri, terutama *Streptococcus* grup A dan *Staphylococcus aureus*, meskipun pada kondisi tertentu infeksi juga dapat disebabkan oleh bakteri maupun jamur lain.

Selain faktor infeksi, berbagai kondisi yang menyebabkan terganggunya integritas kulit maupun menurunnya sistem imun seseorang turut meningkatkan risiko terjadinya selulitis. Individu dengan penyakit kronis seperti diabetes melitus, edema kronis pada tungkai, maupun luka terbuka memiliki kemungkinan lebih besar mengalami infeksi karena bakteri lebih mudah memasuki jaringan tubuh. Oleh karena itu, etiologi selulitis tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan mikroorganisme, tetapi juga oleh kondisi pejamu (host) dan faktor lingkungan yang mendukung terjadinya infeksi (Hasliani, 2021).

Terjadinya selulitis tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan bakteri penyebab infeksi, tetapi juga oleh kondisi pasien yang mempermudah terjadinya invasi mikroorganisme. Kerusakan integritas kulit, diabetes melitus, gangguan sirkulasi perifer, neuropati, penurunan sistem imun, serta higiene yang kurang baik merupakan faktor predisposisi yang meningkatkan risiko terjadinya selulitis, khususnya pada ekstremitas bawah. Kondisi tersebut menyebabkan bakteri lebih mudah berkembang pada jaringan lunak dan memicu proses inflamasi yang progresif (Amalia et al., 2024). Beberapa faktor penyebab selulitis antara lain sebagai berikut.

1. Infeksi *Streptococcus* grup A

Streptococcus grup A merupakan penyebab tersering selulitis. Bakteri ini mudah memasuki jaringan melalui luka pada kulit kemudian menyebabkan inflamasi akut yang ditandai dengan kemerahan, nyeri, edema, dan peningkatan suhu lokal.

2. Infeksi *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang juga sering menyebabkan selulitis. Bakteri ini mampu menginvasi jaringan lunak sehingga menimbulkan infeksi lokal dan dapat berkembang menjadi abses apabila tidak segera ditangani.

3. Infeksi *Streptococcus* grup B

Pada bayi, selulitis dapat disebabkan oleh *Streptococcus* grup B yang menyerang jaringan lunak dan menyebabkan infeksi pada kulit serta jaringan subkutan.

4. Infeksi Jamur

Meskipun jarang terjadi, selulitis juga dapat disebabkan oleh infeksi jamur, salah satunya *Aeromonas hydrophila*, terutama pada individu dengan daya tahan tubuh yang menurun.

5. *Streptococcus pneumoniae*

Selain bakteri utama penyebab selulitis, *Streptococcus pneumoniae* juga dapat menjadi penyebab infeksi jaringan lunak pada kondisi tertentu.

6. Gigitan Hewan, Serangga, atau Manusia

Gigitan dapat menyebabkan kerusakan integritas kulit sehingga menjadi pintu masuk bagi berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Risiko selulitis meningkat apabila luka tidak segera dibersihkan dan ditangani dengan baik.

7. Kulit Kering atau Pecah-Pecah

Kulit yang kering dan mengalami fisura mempermudah masuknya bakteri ke dalam jaringan subkutan sehingga meningkatkan risiko terjadinya selulitis.

8. Luka Bakar atau Lepuh

Kerusakan jaringan akibat luka bakar maupun lepuhan menyebabkan hilangnya fungsi proteksi kulit sehingga bakteri lebih mudah menginvasi jaringan di bawahnya.

9. Diabetes Mellitus

Penderita diabetes melitus memiliki risiko lebih tinggi mengalami selulitis karena kadar glukosa darah yang tinggi dapat menurunkan fungsi sistem imun dan memperlambat proses penyembuhan luka.

10. Pembengkakan Kronis pada Kaki

Edema kronis menyebabkan sirkulasi darah terganggu sehingga meningkatkan risiko infeksi jaringan lunak, terutama pada ekstremitas bawah.

11. Cacar Air

Lesi kulit akibat cacar air dapat menjadi pintu masuk bakteri sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi sekunder berupa selulitis.

C. Klasifikasi

Selulitis dapat diklasifikasikan berdasarkan luas penyebaran infeksi, karakteristik eksudat, serta ruang anatomi yang terkena. Klasifikasi ini penting untuk menentukan tingkat keparahan penyakit, lokasi penyebaran infeksi, serta

penatalaksanaan yang tepat. Secara umum, selulitis dibedakan menjadi selulitis sirkumskripta, selulitis difus akut, dan selulitis kronis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik klinis yang berbeda, mulai dari infeksi yang terbatas pada satu ruang anatomi hingga infeksi yang menyebar luas dan berpotensi mengancam jiwa. Salah satu bentuk selulitis difus yang paling sering dijumpai adalah Angina Ludwig, yaitu infeksi yang mengenai dasar mulut dan ruang submandibular sehingga dapat menyebabkan obstruksi jalan napas apabila tidak segera ditangani (Dinarti et al., 2020).

Adapun klasifikasi selulitis meliputi sebagai berikut.

1. Selulitis Sirkumskripta Serosa Akut

Selulitis sirkumskripta serosa akut merupakan infeksi yang terbatas pada satu atau dua ruang fasial dengan batas yang tidak jelas. Jenis ini ditandai oleh infiltrasi cairan serosa sehingga jaringan terasa lunak dan sponsius. Penamaan selulitis didasarkan pada ruang anatomi yang mengalami infeksi.

2. Selulitis Sirkumskripta Supuratif Akut

Selulitis sirkumskripta supuratif akut memiliki proses yang hampir sama dengan selulitis serosa akut, tetapi telah disertai pembentukan pus atau eksudat purulen. Terbentuknya pus menunjukkan adanya mekanisme pertahanan tubuh yang berusaha membatasi penyebaran infeksi.

3. Selulitis Difus Akut

Selulitis difus akut merupakan infeksi yang menyebar luas pada jaringan lunak dan dapat berkembang dengan cepat apabila tidak mendapatkan penanganan yang adekuat. Jenis ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- Ludwig's Angina.
- Selulitis yang berasal dari ruang inframandibular.
- Selulitis Senator's Difus Parapharyngeal.
- Selulitis Fasialis Difus.
- Necrotizing Fasciitis dan bentuk atipikal lainnya.

4. Selulitis Kronis

Selulitis kronis merupakan proses infeksi yang berlangsung secara lambat akibat virulensi bakteri yang relatif rendah. Kondisi ini umumnya terjadi pada pasien yang tidak mendapatkan terapi maupun drainase secara adekuat sehingga infeksi berlangsung dalam waktu yang lama.

5. Angina Ludwig (Phlegmone)

Angina Ludwig merupakan bentuk selulitis difus yang paling sering ditemukan. Infeksi mengenai ruang sublingual, submental, dan submandibular secara bilateral, bahkan dapat meluas ke ruang faring. Kondisi ini termasuk kegawatdaruratan karena dapat menyebabkan sumbatan jalan napas sehingga memerlukan penanganan segera.

D. *Sign and Symptom*

Manifestasi klinis selulitis muncul sebagai akibat proses inflamasi akut pada kulit dan jaringan subkutan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Gejala yang timbul dapat bersifat lokal maupun sistemik, bergantung pada luas penyebaran infeksi dan kondisi sistem imun pasien. Pada umumnya pasien datang dengan keluhan kemerahan, pembengkakan, nyeri, serta rasa hangat pada daerah yang mengalami infeksi. Apabila infeksi semakin berat, pasien dapat mengalami demam, nyeri otot, serta tanda-tanda infeksi sistemik lainnya. Pengenalan manifestasi klinis secara dini sangat penting untuk mempercepat diagnosis dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat (Hasliani, 2021).

Secara klinis, selulitis paling sering terjadi pada ekstremitas bawah dengan karakteristik berupa makula eritematosa yang tidak memiliki batas tegas, disertai pembengkakan, nyeri tekan, peningkatan suhu lokal, serta indurasi pada jaringan yang mengalami infeksi. Pada kondisi yang lebih berat dapat ditemukan bula, nekrosis epidermis, maupun limfadenopati regional akibat penyebaran proses inflamasi ke jaringan yang lebih dalam (Amalia et al., 2024).

Manifestasi klinis yang sering ditemukan pada pasien selulitis meliputi sebagai berikut.

1. Kemerahan pada Kulit

Daerah yang mengalami infeksi tampak kemerahan akibat proses inflamasi dan peningkatan aliran darah menuju jaringan yang terinfeksi.

2. Pembengkakan (Edema)

Terjadi pembengkakan pada jaringan akibat peningkatan permeabilitas kapiler dan akumulasi cairan selama proses inflamasi.

3. Kulit Terasa Hangat

Daerah yang terinfeksi akan terasa lebih hangat dibandingkan jaringan di sekitarnya sebagai respons terhadap proses peradangan.

4. Nyeri Tekan

Pasien umumnya mengeluhkan nyeri pada lokasi infeksi, terutama ketika area tersebut disentuh atau diberikan tekanan.

5. Kulit Tampak Licin

Permukaan kulit menjadi tegang dan tampak mengilap akibat adanya edema pada jaringan subkutan.

6. Ruam dengan Batas Tegas

Ruam kemerahan dapat muncul secara tiba-tiba dan memiliki batas yang cukup jelas pada daerah yang mengalami infeksi.

7. Memar atau Lepuhan

Pada beberapa kasus dapat ditemukan memar maupun lepuhan kecil sebagai akibat kerusakan jaringan yang lebih berat.

8. Demam

Demam merupakan manifestasi sistemik yang menunjukkan respons tubuh terhadap proses infeksi.

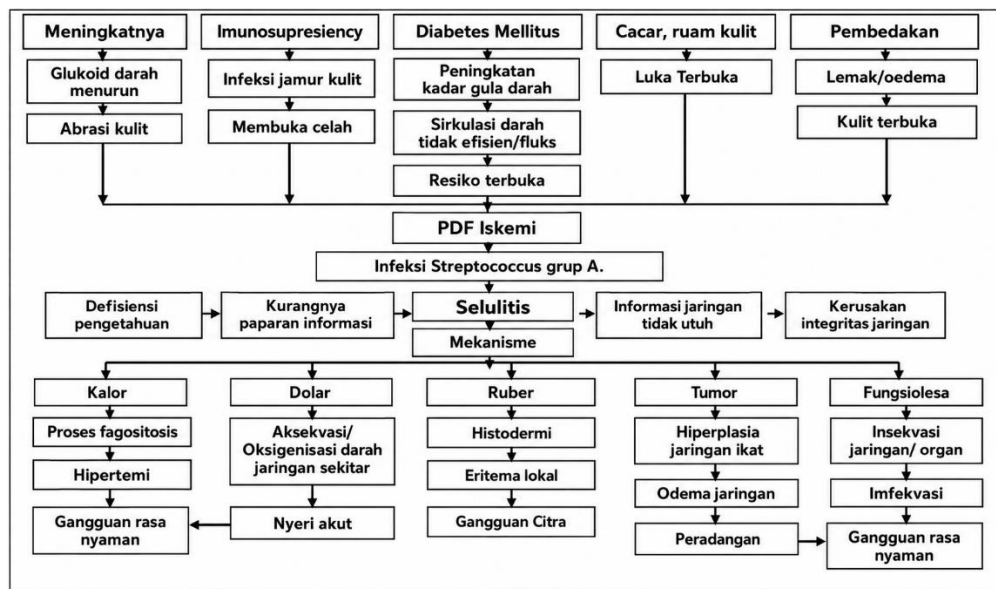
9. Infeksi Jamur di Sela Jari Kaki

Infeksi jamur pada sela-sela jari kaki dapat menjadi faktor predisposisi sekaligus ditemukan bersamaan pada pasien dengan selulitis pedis.

10. Nyeri Otot

Sebagian pasien mengeluhkan nyeri otot sebagai bagian dari respons inflamasi sistemik yang menyertai infeksi.

E. Pathway



Sumber: Hasliani (2021)

F. Komplikasi

Selulitis merupakan infeksi jaringan lunak yang dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat apabila tidak mendapatkan penatalaksanaan secara cepat dan adekuat. Penyebaran infeksi yang terus berlangsung dapat menyebabkan kerusakan jaringan, penyebaran bakteri ke aliran darah, maupun keterlibatan organ lain. Tingkat keparahan komplikasi dipengaruhi oleh luas infeksi, daya tahan tubuh pasien, serta ketepatan terapi yang diberikan. Oleh karena itu, pengobatan yang tepat dan pemantauan kondisi pasien secara berkala sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi yang dapat mengancam jiwa (Hasliani, 2021).

Apabila tidak mendapatkan terapi yang adekuat, selulitis dapat mengalami penyebaran ke jaringan yang lebih dalam sehingga meningkatkan risiko terjadinya berbagai komplikasi. Infeksi yang berlanjut dapat menyebabkan gangren, abses jaringan lunak, osteomielitis, *necrotizing*

fasciitis, tromboflebitis pada selulitis ekstremitas bawah, hingga sepsis yang berpotensi mengancam jiwa. Oleh karena itu, identifikasi dini serta terapi antibiotik yang tepat menjadi faktor penting dalam mencegah perkembangan komplikasi tersebut (Amalia et al., 2024).

Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien selulitis antara lain sebagai berikut.

- 1. Abses**

Infeksi yang berlanjut dapat menyebabkan terbentuknya kumpulan pus pada jaringan lunak sehingga memerlukan tindakan insisi dan drainase.

- 2. Nekrosis Kulit (*Cellulitis Gangren*)**

Kerusakan jaringan yang berat dapat menyebabkan nekrosis kulit akibat gangguan perfusi dan proses infeksi yang terus berkembang.

- 3. Myonecrosis**

Infeksi dapat meluas hingga mengenai jaringan otot sehingga menyebabkan kerusakan otot yang bersifat progresif.

- 4. Fasciitis**

Penyebaran infeksi ke jaringan fascia dapat menyebabkan fasciitis yang bersifat berat dan memerlukan penanganan segera.

- 5. Carpal Tunnel Syndrome Akut**

Pada selulitis ekstremitas atas, pembengkakan jaringan dapat meningkatkan tekanan pada terowongan karpal sehingga menimbulkan sindrom terowongan karpal akut.

- 6. Osteomyelitis**

Infeksi yang menyebar hingga jaringan tulang dapat menyebabkan osteomyelitis sehingga memperpanjang proses penyembuhan.

- 7. Thrombophlebitis**

Peradangan pada vena yang disertai pembentukan trombus dapat terjadi terutama pada selulitis yang mengenai ekstremitas bawah.

8. Bakteremia

Masuknya bakteri ke dalam sirkulasi darah dapat menyebabkan penyebaran infeksi ke berbagai organ tubuh.

9. Demam Scarlet

Pada beberapa kasus infeksi *Streptococcus*, selulitis dapat disertai komplikasi berupa demam scarlet meskipun kejadiannya relatif jarang.

10. Syok Sepsis dan Kegagalan Multi Organ

Infeksi berat yang tidak tertangani dapat menyebabkan pelepasan toksin bakteri secara sistemik sehingga berkembang menjadi sepsis, syok septik, hingga kegagalan multi organ.

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada pasien selulitis dilakukan untuk membantu menegaskan diagnosis, menentukan luas dan tingkat keparahan infeksi, mengidentifikasi mikroorganisme penyebab, serta mendeteksi kemungkinan komplikasi yang terjadi. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar dalam menentukan terapi yang tepat, terutama pemilihan antibiotik dan tindakan bedah apabila diperlukan. Pemeriksaan laboratorium maupun radiologi dipilih sesuai kondisi klinis pasien dan tingkat keparahan infeksi (Hasliani, 2021).

Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien selulitis antara lain sebagai berikut.

1. Complete Blood Count (CBC)

Pemeriksaan darah lengkap dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan jumlah leukosit dan laju endap darah yang mengindikasikan terjadinya proses infeksi bakteri.

2. Kultur Darah

Kultur darah dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri, jamur, maupun mikroorganisme lain di dalam aliran darah serta membantu menentukan jenis antibiotik yang sesuai.

3. Kultur Cairan Luka

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel cairan luka untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi sehingga terapi dapat diberikan secara lebih spesifik.

4. Pemeriksaan Rontgen

Foto rontgen digunakan untuk menilai adanya penyebaran infeksi ke jaringan yang lebih dalam maupun mendeteksi keterlibatan tulang pada kasus tertentu.

5. Magnetic Resonance Imaging (MRI)

MRI digunakan pada kasus selulitis berat untuk mengetahui luas penyebaran infeksi, mendeteksi pembentukan abses, pyomyositis, maupun necrotizing fasciitis sehingga dapat membantu menentukan tindakan medis selanjutnya.

H. Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan selulitis bertujuan mengeradikasi mikroorganisme penyebab infeksi, mengurangi proses inflamasi, mempercepat penyembuhan jaringan, serta mencegah terjadinya komplikasi. Terapi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat keparahan infeksi, kondisi umum pasien, adanya penyakit penyerta, serta keberadaan abses maupun komplikasi lain. Selain pemberian antibiotik, perawatan luka yang baik, tindakan bedah bila diperlukan, serta edukasi kepada pasien merupakan bagian penting dalam keberhasilan terapi (Hasliani, 2021).

Penatalaksanaan selulitis memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui terapi farmakologis maupun nonfarmakologis. Selain pemberian antibiotik sesuai penyebab infeksi, tindakan debridement pada jaringan nekrotik, drainase apabila terdapat abses, serta perawatan luka yang dilakukan dengan prinsip aseptik berperan penting dalam mengendalikan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Pendekatan tersebut perlu disertai pemantauan kondisi luka secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan penyembuhan jaringan (Amalia et al., 2024).

Penatalaksanaan medis pada pasien selulitis meliputi sebagai berikut.

1. Pemberian Antibiotik

Antibiotik diberikan untuk mengatasi infeksi bakteri penyebab selulitis. Pada kasus pascatrauma atau gigitan hewan, antibiotik dipilih yang mampu mengatasi bakteri gram positif maupun gram negatif.

2. Pemberian Analgesik dan NSAID

Obat analgesik dan antiinflamasi nonsteroid diberikan untuk mengurangi nyeri, menurunkan demam, serta meningkatkan kenyamanan pasien.

3. Insisi dan Drainase

Apabila telah terbentuk abses, dilakukan tindakan insisi dan drainase untuk mengeluarkan pus dari jaringan lunak. Prosedur dilakukan dengan anestesi lokal, aspirasi pus, insisi, kemudian pemasangan drain bila diperlukan.

Pada pasien dengan selulitis pedis yang disertai diabetes melitus, pengendalian kadar glukosa darah merupakan bagian penting dari terapi karena hiperglikemia dapat memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Kombinasi terapi antibiotik dan insulin terbukti menjadi pilihan terapi yang efektif pada pasien dengan selulitis pedis dan diabetes yang tidak terkontrol sehingga dapat memperbaiki kondisi infeksi sekaligus membantu mencapai kontrol glikemik yang lebih baik (Julaeha & Farisma, 2022).

4. Antibiotik Intravena

Pada pasien dengan infeksi sedang hingga berat atau yang memerlukan perawatan di rumah sakit, diberikan antibiotik intravena seperti penisilin atau golongan sejenis, misalnya cloxacillin.

5. Antibiotik Oral

Pada kasus selulitis ringan, terapi dapat diberikan menggunakan antibiotik oral sesuai kondisi klinis pasien.

6. Elevasi Ekstremitas

Apabila selulitis mengenai tungkai, ekstremitas dianjurkan diposisikan lebih tinggi untuk membantu mengurangi edema dan meningkatkan sirkulasi vena. Pada pengkajian ekstremitas, perawat perlu melakukan observasi secara menyeluruh terhadap kondisi luka, meliputi ukuran luka, kedalaman, warna dasar luka, jumlah dan jenis eksudat, jaringan nekrotik, jaringan granulasi, edema, bau luka, serta tanda-tanda infeksi. Pengkajian yang komprehensif akan membantu menentukan tingkat keparahan luka, memantau perkembangan penyembuhan, dan menjadi dasar dalam penyusunan intervensi keperawatan yang tepat (Amalia et al., 2024).

7. Kompres Dingin

Kompres dingin dapat diberikan untuk membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan pada area yang mengalami inflamasi.

8. Terapi Antibiotik Rawat Jalan

Setelah kondisi pasien membaik, terapi dapat dilanjutkan secara rawat jalan menggunakan antibiotik oral, seperti eritromisin atau penisilin sesuai indikasi medis.

9. Monitoring Perkembangan Infeksi

Selama terapi berlangsung dilakukan pemantauan terhadap respons pasien, perkembangan luka, tanda-tanda infeksi, serta kemungkinan munculnya komplikasi sehingga terapi dapat dievaluasi secara berkala.

I. Fokus Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang bertujuan memperoleh data secara komprehensif mengenai kondisi pasien. Pada pasien dengan selulitis, pengkajian difokuskan pada identifikasi tanda dan gejala infeksi, luas kerusakan jaringan, faktor risiko yang mendasari terjadinya infeksi, serta dampaknya terhadap kebutuhan dasar pasien. Data yang diperoleh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan penunjang

menjadi dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan, penyusunan intervensi, serta evaluasi keberhasilan tindakan keperawatan (PPNI, 2017).

1. Data Umum

Meliputi identitas pasien yang terdiri atas nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor rekam medis, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, diagnosis medis, serta identitas penanggung jawab pasien.

2. Riwayat Kesehatan

a. Keluhan Utama

Pasien umumnya mengeluhkan nyeri pada daerah yang mengalami infeksi, disertai pembengkakan, kemerahan, dan kesulitan menggerakkan ekstremitas yang terkena.

b. Riwayat Kesehatan Sekarang

Dikaji mengenai waktu munculnya keluhan, lokasi infeksi, perkembangan luka, adanya demam, riwayat trauma, luka terbuka, gigitan serangga atau hewan, luka operasi, maupun infeksi kulit sebelumnya.

c. Riwayat Kesehatan Dahulu

Perlu dikaji adanya riwayat penyakit yang dapat meningkatkan risiko selulitis, seperti diabetes mellitus, gangguan sirkulasi perifer, edema kronis, penyakit kulit, maupun riwayat selulitis sebelumnya.

d. Riwayat Kesehatan Keluarga

Dikaji adanya anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gangguan imun, maupun penyakit lain yang berhubungan dengan kondisi pasien.

3. Pola Fungsi Kesehatan

a. Pola Persepsi dan Manajemen Kesehatan

Perlu dikaji tingkat pengetahuan pasien mengenai penyakit yang dialami, penyebab infeksi, kepatuhan terhadap pengobatan, serta kebiasaan dalam menjaga kebersihan diri dan perawatan luka.

b. Pola Nutrisi dan Metabolik

Pasien dapat mengalami penurunan nafsu makan akibat proses infeksi. Selain itu dikaji status hidrasi, pola makan, berat badan, serta kecukupan asupan kalori dan protein untuk menunjang penyembuhan luka.

c. Pola Eliminasi

Dikaji frekuensi buang air kecil dan buang air besar, termasuk adanya gangguan eliminasi yang dapat memengaruhi kondisi umum pasien.

d. Pola Aktivitas dan Latihan

Pasien biasanya mengalami keterbatasan aktivitas akibat nyeri, edema, dan gangguan fungsi pada ekstremitas yang mengalami selulitis.

e. Pola Istirahat dan Tidur

Nyeri dan rasa tidak nyaman sering menyebabkan gangguan tidur sehingga kualitas dan durasi istirahat pasien perlu dikaji.

f. Pola Kognitif dan Perseptual

Dikaji tingkat kesadaran, kemampuan berkomunikasi, persepsi terhadap nyeri, serta kemampuan pasien memahami informasi yang diberikan.

g. Pola Persepsi Diri

Kerusakan kulit, pembengkakan, maupun perubahan bentuk ekstremitas dapat memengaruhi citra tubuh dan kepercayaan diri pasien.

h. Pola Peran dan Hubungan

Infeksi dan keterbatasan aktivitas dapat menyebabkan perubahan peran pasien di lingkungan keluarga maupun pekerjaan.

i. Pola Koping dan Toleransi Stres

Dikaji respons psikologis pasien terhadap penyakit yang dialami, mekanisme koping, serta dukungan keluarga selama menjalani perawatan.

j. Pola Nilai dan Keyakinan

Perlu dikaji apakah kondisi penyakit memengaruhi pelaksanaan ibadah maupun keyakinan pasien selama menjalani perawatan.

k. Pola Seksual dan Reproduksi

Dikaji bila diperlukan, terutama apabila kondisi penyakit memengaruhi aktivitas seksual maupun kesehatan reproduksi pasien.

4. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

Pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan untuk mengetahui kondisi umum pasien dan mendeteksi adanya respons sistemik terhadap infeksi, meliputi:

- a. Tekanan darah.
- b. Frekuensi nadi.
- c. Frekuensi pernapasan.
- d. Suhu tubuh.
- e. Saturasi oksigen (bila diperlukan).

5. Pemeriksaan Fisik (Head to Toe)

a. Kepala

Bentuk kepala simetris, kesadaran compos mentis, dan tidak ditemukan kelainan khusus.

b. Mata

Konjungtiva dinilai untuk mengetahui adanya tanda anemia atau infeksi sistemik.

c. Hidung

Dikaji adanya gangguan pernapasan maupun sekret yang berlebihan.

d. Mulut

Mukosa mulut dinilai tingkat kelembapannya serta kebersihan rongga mulut.

e. Leher

Dikaji adanya pembesaran kelenjar getah bening yang dapat menunjukkan penyebaran infeksi.

f. Thoraks

Dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk mengetahui adanya gangguan sistem pernapasan apabila infeksi telah berkembang menjadi sistemik.

g. Abdomen

Dilakukan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi untuk mengetahui kondisi umum sistem pencernaan.

h. Ekstremitas

Merupakan fokus utama pengkajian. Perawat mengkaji lokasi infeksi, luas luka, warna kulit, edema, peningkatan suhu lokal, nyeri tekan, adanya drainase, bau luka, jaringan nekrotik, serta kemampuan ekstremitas dalam melakukan pergerakan.

i. Integumen

Dikaji adanya kemerahan (*rubor*), pembengkakan (*tumor*), peningkatan suhu (*kalor*), nyeri (*dolor*), kerusakan integritas kulit, serta tanda-tanda penyebaran infeksi.

J. Diagnosa Keperawatan (SDKI)

1. Nyeri Akut (D.0077) berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (proses inflamasi akibat infeksi bakteri pada jaringan kulit dan subkutan).
2. Gangguan Integritas Kulit dan Jaringan (D.0129) berhubungan dengan kerusakan jaringan akibat proses infeksi bakteri.
3. Gangguan Citra Tubuh (D.0083) berhubungan dengan perubahan struktur dan penampilan kulit akibat selulitis.
4. Defisit Pengetahuan (D.0111) berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai penyakit, pengobatan, dan perawatan luka.
5. Gangguan Rasa Nyaman (D.0074) berhubungan dengan proses inflamasi dan hipertermia akibat infeksi.

K. Fokus Intervensi (SLKI)

SDKI	SLKI	SIKI
Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 × 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil Tingkat Nyeri (L.08066): 1. Keluhan nyeri menurun (5). 2. Meringis menurun (5). 3. Sikap protektif menurun (5). Keterangan: 1 = Meningkat 2 = Cukup meningkat 3 = Sedang 4 = Cukup menurun 5 = Menurun	Manajemen Nyeri (I.08238) <i>Observasi</i> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 2. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. <i>Terapeutik</i> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (relaksasi). 2. Fasilitasi istirahat dan tidur. <i>Edukasi</i> 1. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 2. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri. <i>Kolaborasi</i> 1. Kolaborasi pemberian obat analgetik.
Gangguan Integritas	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 × 24	Perawatan Luka (I.14564) <i>Observasi</i>

Kulit dan Jaringan berhubungan dengan neuropati perifer	jam diharapkan integritas kulit dan jaringan membaik dengan kriteria hasil Integritas Kulit dan Jaringan (L.14125): 1. Kerusakan jaringan menurun (5). 2. Kerusakan lapisan kulit menurun (5). 3. Nekrosis menurun (5). Keterangan: 1 = Meningkat 2 = Cukup meningkat 3 = Sedang 4 = Cukup menurun 5 = Menurun	1. Monitor drainase, warna, ukuran, dan bau luka. 2. Monitor tanda-tanda infeksi. <i>Terapeutik</i> 1. Lepaskan balutan dan plester secara perlahan. 2. Bersihkan luka dengan larutan NaCl atau cairan pembersih non toksik. 3. Bersihkan jaringan nekrotik. 4. Pertahankan teknik steril selama perawatan luka. 5. Pasang balutan sesuai jenis luka. <i>Edukasi</i> 1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 2. Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi protein. 3. Anjurkan melakukan perawatan luka secara mandiri. <i>Kolaborasi</i> 1. Kolaborasi pemberian antibiotik sesuai program terapi.
--	---	---

Selain terapi farmakologis, manajemen nyeri pada pasien selulitis dapat dilakukan melalui berbagai teknik nonfarmakologis, seperti relaksasi napas dalam maupun terapi relaksasi genggam jari. Pendekatan ini terbukti membantu menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan kenyamanan, serta memperbaiki kualitas tidur pasien sehingga dapat mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh (Mulyana & Haryeti, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Pahria, T., & Harun, H. (2024). *Perawatan luka dan manajemen nyeri pada pasien dengan selulitis: Studi kasus*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(4).
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2567>
- Dinarti, Budiyo, A., Pudjiati, S., Siswati, R., Febriana., & Rayinda. (2020). *Clinical Decision Making Series: Dermatologi dan Venereologi*. Gadjah Mada University Press.
- Hasliani. (2021). *Sistem Integumen*. CV Tohar Media.
- Julaeha, J., & Farisma, N. (2022). *Laporan kasus selulitis pedis pada diabetes melitus tipe 2 dengan terapi antibiotik dan insulin*. Journal Borneo: Science Technology and Health Journal, 2(1), 20–25.
- Mulyana, E. A., & Haryeti, P. (2025). *Penerapan terapi genggam jari untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasien selulitis pedis dengan komplikasi diabetes mellitus: Laporan kasus*. Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan, 15(2), 52–61.
- PPNI, Tim Pokja SDKI DPP. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI, Tim Pokja SIKI DPP. (2017). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI, Tim Pokja SLKI DPP. (2017). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Wiederhold, A. K., Cartuliales, M. B., Jeppesen, K., & Skjøt-Arkil, H. (2024). *Characteristics and antibiotic treatment of patients with cellulitis in the emergency department*. Antibiotics, 13(11), 1021.
<https://doi.org/10.3390/antibiotics13111021>